

SH.EQR.06.ACT.13			رقم السياسة
الوصول الى وحدات الرعاية المتخصصة			عنوان السياسة
1	رقم الإصدار	2026/03/01	تاريخ إعداد
2026/04/01	تاريخ اعتماد	2026/04/05	تاريخ تفعيل
12	عدد الصفحات	2029/04/01	تاريخ المراجعة
• الرعاية المركزة • رعاية القلب • الحضانة • وحدة السكتة الدماغية • الرعاية الجراحية			نطاق التفعيل
اعتماد		مراجعة	إعداد
مدير المستشفى د/ وسام وهيبه		لجنة الجودة د/ ايمان سامي	مدير الشؤون العلاجية د/ محمد مختار فريق الجودة د/ باسل محمد - م/ ولاء سيد



د/ ايمان سامي السيد
 مديرة الجودة
 مستشفى سيدناوي

السياسة

- تمتلك كل وحدة خاصة قائمة مفصلة بمعايير الدخول والخروج مبنية على معايير إكلينيكية وفسيولوجية.
- تكون هذه المعايير معتمدة من (رئيس القسم المعني، مدير الشؤون العلاجية، ومدير المستشفى).
- تكون المعايير معلنة ومتاحة لجميع العاملين بالوحدة (معلقة داخل القسم أو متاحة إلكترونياً للعاملين).
- يقتصر إعطاء أمر الدخول أو الخروج على الأطباء المصرح لهم (الاستشاري أو الأخصائي المتواجد بالتنسيق مع الاستشاري).

الغرض

- ضمان الاستخدام الأمثل للموارد السريرية والأسرة بالوحدات الخاصة.
- توفير الرعاية الطبية الفائقة للمرضى الذين يحتاجون إليها بناءً على معايير فسيولوجية وإكلينيكية.
- التوحيد القياسي لقرارات الدخول والخروج لضمان سلامة المرضى ومنع الدخول أو البقاء غير المبرر.

التعريفات

الوحدات الخاصة : هي الأقسام التي تقدم رعاية ومراقبة طبية وتمريضية مكثفة للمرضى الذين يعانون من حالات حرجية أو مهددة للحياة.

إجراءات العمل

إجراءات الدخول:

1. يقوم الطبيب المعالج أو طبيب الطوارئ بتقييم حالة المريض والتواصل مع أخصائي/استشاري الوحدة الخاصة.
2. يقوم طبيب الوحدة الخاصة بمطابقة حالة المريض الإكلينيكية مع معايير الدخول المعتمدة الخاصة بالوحدة.
3. في حال الموافقة، يُصدر الطبيب أمر دخول للقسم الخاص (سواء في نموذج اخطار الفحص بالاستقبال او نموذج الاستشارة الطبية داخل المستشفى)
4. يلتزم الطبيب بكتابة التقييم الطبي وسبب الدخول بوضوح في نماذج الملف الطبي، بما يثبت استيفاء المريض لمعايير الدخول.

إجراءات الخروج / النقل:

1. يتم التقييم اليومي للمرضى داخل الوحدة الخاصة لتحديد مدى استقرارهم.
2. عند استيفاء المريض لمعايير الخروج أو تحسن حالته لدرجة تسمح بنقله لمستوى رعاية أقل (Step-down)، يتخذ الاستشاري/الأخصائي قرار الخروج.
3. يتم توثيق أمر النقل/الخروج في الملف الطبي مدعوماً بملخص طبي يوضح استقرار العلامات الحيوية والفسيولوجية.

المسؤول عن التنفيذ

- إدارة المستشفى ومدير الشؤون العلاجية: اعتماد المعايير وتوفير الموارد.
- رؤساء الوحدات الخاصة: وضع المعايير وتحديثها، وتدريب الطاقم عليها.
- الأطباء: الالتزام بالمعايير بدقة، وتوثيق القرارات في الملف الطبي.
- التمريض: تسهيل عملية النقل والدخول، وإبلاغ الأطباء بأي تحسن أو تدهور.

المراقبة والتقييم

- تتبع مؤشرات الأداء المرتبطة ب إعادة دخول المرضى الى المستشفى خلال مدة محددة
- مراجعة نماذج الملف الطبي

النماذج / المرفقات

- قوائم معايير الدخول والخروج
- نموذج النقل الداخلي
- صحيفة الدخول والخروج
- نموذج الاستشارة الطبية

معايير ذات صلة

ACT.07 Patient's care responsibility, ICD.01 Uniform care, ACT.01 Granting access (before patient's registration), ICD.15 Plan of Care, CSS.01 Critical care.

المراجع:

دليل معايير اعتماد المستشفيات -الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، إصدار 2025. (معييار ACT.13)



الهيئة العامة للتأمين الصحي

فروع:

المصنّف:

اسم المريض:

رقم الملف الطبي للمريض:

القسم المعالج :

صحيفة الدخول والخروج

[illegible]



اسم المريض:
رقم الملف الطبي للمريض:
القسم المعالج :

الهيئة العامة للتأمين الصحي
فرع:
المستشفى :

Consultation Request Form

نموذج إستشارة طبية

السن : النوع : تاريخ الدخول : / /
To : Specialty: Consultation only ☐ Consultation & follow-up ☐
Doctor : Type of Consultation: Urgent ☐ Routine ☐ with inHour/s

Reason for consultation:

.....
.....
.....
.....

Doctor's Name: Signature: Date: / / Time

Consultation Reply

Medical Opinion:
.....
.....

Plan to be followed :

Investigation :

.....

Treatment:

.....
.....

Follow up:

.....
.....

Doctor 's Name: Signature : Date : / / Time:.....



فروع:

المستفي:

MR.ER.1-1



اسم المريض :
 رقم الملف الطبي للمريض:
 القسم المعالج :
 الهيئة العامة للتأمين الصحي
 فرع:
 المستشفى:

نموذج تحويل داخلي
Transfer Form

تاريخ الدخول :	النوع :
رقم التأمين :	
التشخيص : ملخص الحالة :	
القسم المحول منه :	التاريخ : الساعة :
القسم المحول اليه :	
١ - تسليم الملف :	
٢ - نتائج المعمل :	
الاشعاعات :	
Vital Signs :	
سبب التحويل :	
الطبيب المحول :	الطبيب المستلم :

التمريض المحول التمريض المستلم تاريخ التسليم ساعة التسليم

.....

Admission criteria for the NICU

1. Age: 0-28 days
2. Preterm infant 32 weeks gestation +/- respiratory distress
3. VLBW infant <1500 gm.
4. Affected infant born to high risk pregnancy and delivery
5. Any neonate (full or preterm) with respiratory distress requires any form of respiratory support either O2 nasal, CPAP or mechanical ventilation
6. Infant of diabetic mother
7. Hyperbilirubinemia, requires phototherapy, or exchange transfusion
8. Neonatal sepsis: with poor suckling , poor activity , hypothermia , unstable vitals / hemodynamic instability
9. Infant with hemodynamic compromise (shock)
10. Hypothermia
11. Infant with seizures or hypoxic ischemic injury
12. Infant with abnormal neurological examination
13. Recurrent apnea/ cyanosis
14. Infant with pneumonia or sepsis

Discharge criteria for the NICU

1. Stable vital signs and temperature for 24 hours
2. Adequate weight gain
3. Minimum discharge weight of 1600-1700 gm attained
4. Ability to be fed by breast or bottle without respiratory compromise
5. Tolerate oral feeding or if long term plan is NG tube Feeding, tolerate feeds and family have been trained
6. Tolerates medications prescribed orally
7. Normal lab values
 - Fair CBC
 - Normal Blood chemistry
 - No electrolyte abnormalities
 - Normal kidney function
 - Fair CRP

Admission Criteria for CCU

Patients are admitted when they need continuous cardiac monitoring and intensive care:

1. Acute Coronary Syndromes
 - ST-elevation MI (STEMI)
 - Non-ST elevation MI (NSTEMI)
 - Unstable angina with high risk features
2. Serious Arrhythmias
 - Ventricular tachycardia (VT) vor ventricular fibrillation (VF)
 - Symptomatic bradycardia (may need pacing)
 - High-grade AV block (2nd degree type II or 3rd degree)
3. Acute Heart Failure
 - Pulmonary edema
 - Cardiogenic shock
4. Hemodynamic Instability
 - Hypotension requiring vasopressors/inotropes
 - Shock (cardiogenic or mixed)
5. Post-Cardiac Arrest Care
 - After return of spontaneous circulation (ROSC)
6. Post-Cardiac Procedures
 - After PCI (angioplasty) with complications
 - Post cardiac surgery (early phase if unstable)
7. Other High-Risk Conditions
 - Aortic dissection
 - Massive pulmonary embolism
 - Severe hypertensive emergencies with cardiac involvement

Discharge Criteria from CCU

Patients can be transferred to a step-down unit or ward when they are stable and no longer need intensive monitoring:

1. Hemodynamic Stability
 - Stable blood pressure without IV support
 - No signs of shock
2. Stable Cardiac Rhythm
 - No life-threatening arrhythmias
 - Controlled heart rate
3. Improved Symptoms
 - No ongoing chest pain
 - No acute dyspnea or pulmonary edema
4. No Need for Intensive Monitoring
 - No requirement for continuous invasive monitoring
 - No temporary pacing or mechanical support
5. Post-MI Stabilization
 - Completed acute phase (usually 24–72 hours depending on severity)
 - No complications (e.g., recurrent ischemia, arrhythmias)
6. Improved Heart Failure Status
 - Off IV diuretics/inotropes
 - Stable on oral medications
7. Post-Procedure Stability :
 - Stable after PCI or surgery without complications

CRITERIA For ICU Admission

1. NEUROLOGY

Glasgow Coma Scale (GCS):

- GCS < 9. (This must be a *new change* and not a chronic baseline)
- Rapid deterioration in conscious level by 3 or more points.
- GCS < 12 with bulbar symptoms.

Intracerebral Hemorrhage (ICH):

- **ICU Admission:** Any case of recent ICH "within 24 hours" (with or without decreased conscious level) for observation for 24-48 hours with follow-up CT brain, provided it is not for surgical intervention.
- **Convulsions:** Fits not responding to ER measures (single slow IV dose of Dormicum 0.2 mg/kg).
- **Massive MCA Infarction:** To be admitted under observation for 24 - 48 hours.

2. NEPHROLOGY & ELECTROLYTES

Hyponatremia:

- ICU Admission: Serum Na < 110 mEq.
- ICU Admission: Serum Na > 110 mEq *with symptoms*.
 - Ward Admission: Serum Na > 110 mEq without symptoms, under nephrology supervision (provided there is no other internal medicine cause).

Diluted Hyponatremia:

- With congestive heart failure → Admitted under Cardiology.
- With decompensated liver cell failure → Admitted under Internal Medicine.

Potassium Disorders:

- Hypokalemia: Serum K < 2.5 → *ICU admission*. (Serum K ≥ 2.5 → Ward admission).
- Hyperkalemia: Serum K > 6, or with significant ECG changes → *ICU admission*.

Calcium Disorders:

- Serum Calcium > 12 mg/dl, or < 6 mg/dl with manifestations → *ICU admission*.

3. CHEST

- **Respiratory Rate:** > 30 breaths/min, provided it is due to an *acute/recent respiratory cause* (not a chronic condition like lung fibrosis or merely secondary to fever).
- **Hypoxia:** O2 saturation ≤ 90% on NRM, provided it is due to a *new respiratory pathology*.
- **COPD Exacerbation:** Accompanied by CO2 narcosis (PCO2 > 50) with PH < 7.30, confusion, or Type 2 Respiratory Failure.
- **Asthma Exacerbation:** Accompanied by respiratory alkalosis, silent chest, cyanosis, confusion, or RR > 30 breaths/min.

4. SEPTIC SHOCK & IMPENDING SEPTIC SHOCK

- **ICU Admission:** Systolic BP ≤ 80 mmHg with no response to resuscitation trials at the ER, and must be accompanied by signs of hypo perfusion
- **Borderline BP:** If accompanied by the following: Pulse > 100, confusion, elevated lactate, and very high TLC.

5. ENDOCRINOLOGY

Hypoglycemia:

- Blood glucose ≤ 50 mg/dl with manifestations.
- Recurrent hypoglycemia despite resuscitation trials at the ER with IV glucose bolus.
- **Non-Ketotic Hyperosmolar Hyperglycemia** → *ICU admission*.

Diabetic Ketoacidosis (DKA):

- Admitted to ICU if meeting these criteria: Acetone ++, PH ≤ 7.30, HCO3 ≤ 15, and PCO2 matching expected formula (Expected CO2 = 1.5 * HCO3 + 8 ± 2).

6. GASTROINTESTINAL & HEPATIC (GIT)

- **GIT Bleeding:** Upper or lower GI bleeding with hemodynamic instability, witnessed hematemesis or melena, or continuous Hb drop.
- **Hepatic Encephalopathy:** Grade 3 or more.

7. HEMATOLOGY & OTHERS

- **Anemia:** Hb ≤ 5 gm% → *ICU admission*. (Hb > 5 gm% → Ward admission).
- **Platelet Count:** < 10,000 (without bleeding), or ≤ 20,000 (with active bleeding).
- **High Fever:** Temperature > 40°C.

CRITERIA FOR ICU DISCHARGE

Patient is transferred from the ICU to the regular ward if they meet the following:

1. Patient no longer meets the criteria for ICU admission.
2. Patient no longer needs continuous vital signs monitoring.
3. Patient is off circulatory support for at least 24 hours.
4. Patient is off insulin infusion for at least 24 hours. (For DKA patients: Transfer if Acetone is +, PH > 7.3, HCO3 > 15, and colton. and off insulin infusion for 24 hours).
5. Patient is off glucose infusion for at least 24 hours.
6. For ICH patients: after 24 hours under observation with no change in conscious level, no increase in hemorrhage size (confirmed by follow-up CT brain), and no need for surgical intervention.
7. Correction of serum Na level.
8. Correction of serum K level.

Neurology Intermediate Care & Stroke Unit Protocol

1. Scope of Clinical Services

The Neurology Intermediate Care Unit (NIMCU) provides specialized care and continuous monitoring for patients with acute neurological conditions who do not require invasive mechanical ventilation or vasopressor support.

AVAILABLE SERVICES 	OUT-OF-SCOPE (ICU/REFERRAL) 
- Acute Stroke Management & IV Thrombolysis - Continuous Cardiac & Neuro-monitoring - Plasmapheresis (Plasma Exchange) - Intravenous Immunoglobulin (IVIg) Therapy - Diagnostic Cerebral & Carotid Angiography - Bedside EEG & CSF Analysis - MS Day Care (Pulse Therapy & DMT Infusions)	- Invasive Mechanical Ventilation - Mechanical Thrombectomy (Endovascular) - Neurosurgical Interventions (Craniectomy/EVD) - Invasive ICP Monitoring - Continuous Vasopressor Infusions - Electromyography (EMG) / NCS

2. Admission Criteria

A. Stroke & Cerebrovascular Disorders

CONDITION	NIMCU ADMISSION	ICU TRANSFER INDICATORS
Ischemic Stroke	Acute stroke ≤ 48 h, NIHSS < 15 , stable post-rtPA.	Malignant MCA syndrome, GCS < 9 , brainstem stroke.
TIA	High risk (ABCD2 ≥ 4), crescendo TIAs.	N/A (Observe in NIMCU).
Hemorrhage	Small ICH/SAH, GCS ≥ 12 , stable hemodynamics.	Hydrocephalus, massive mass effect, GCS < 10 .

B. Epilepsy & Seizure Management

NIMCU (STABLE)	ICU (CRITICAL)
- Post-ictal monitoring after status termination - Cluster seizures requiring IV drug adjustment - First-onset seizure with stable sensorium	- Refractory Status Epilepticus - Post-ictal coma requiring airway protection - Seizures with severe metabolic failure

C. Neuromuscular & Autoimmune

PATHOLOGY	NIMCU (FVC > 20 ML/KG)	ICU (FVC < 20 ML/KG)
GBS / CIDP	Stable progression, no bulbar signs.	Autonomic instability, respiratory failure.
Myasthenia Gravis	Exacerbation, stable swallowing.	Myasthenic Crisis, dysphagia, CO2 retention.
MS / NMOSD / TM	Acute relapse, thoracic lesions.	Brainstem/Cervical lesions with respiratory risk.

CRITICAL EXCLUSIONS: Impending airway loss | Shock / Severe hypotension | Massive hemispheric stroke with deterioration | Requirement for mechanical ventilation.

3. MS & Neuro-Immunology Day Care

A dedicated facility forelective one-day procedures:

- Pulse Steroid Therapy:** High-dose IV Methylprednisolone.
- DMT Infusions:** Including Ocrelizumab, Natalizumab, and Rituximab.
- Observation:** Minimum 4-8 hours post-infusion monitoring for adverse reactions.

4. Discharge & Transfer Policy

Transfer to General Ward (Step-Down)

- Neurological and hemodynamic stability for ≥ 48 -72 hours.
- Passed swallow evaluation; stable oral/enteral nutrition.
- SpO2 $> 94\%$ on room air.

Transfer to ICU (Step-Up)

- Decrease in GCS ≥ 2 points.
- New-onset respiratory distress or cardiac instability.
- New focal neurological deficit or worsening NIHSS ≥ 4

Admission Criteria Surgical Intensive Care Unit (SICU)

1. Preoperative preparation admission
2. Postoperative indications
 - a. Major surgeries requiring intensive monitoring (Cardiothoracic, Neurosurgery, major abdominal, vascular, transplant)
 - b. Anticipated postoperative complications
 - c. Requirement for mechanical ventilation
 - d. Hemodynamic instability following surgery
3. Respiratory support
 - a. Acute respiratory failure requiring ventilator support
 - b. Airway compromise or need for airway protection
 - c. Severe hypoxemia or hypercapnia
4. Hemodynamic instability
 - a. Shock (hypovolemic, septic, cardiogenic, obstructive)
 - b. Requirement for vasopressors or inotropes
 - c. Uncontrolled hemorrhage or massive transfusion
 - d. Hypertensive emergencies requiring invasive monitoring
5. Neurological conditions
 - a. Traumatic brain injury or spinal cord injury
 - b. Postoperative neurological monitoring
 - c. Reduced level of consciousness (GCS $\leq$ 8)
 - d. Status epilepticus
6. Severe trauma and burns
 - a. Polytrauma Requiring multidisciplinary care
 - b. Severe burns requiring intensive resuscitation
7. Sepsis and Severe infections
 - a. SEPSIS OR SEPTIC SHOCK
 - b. Intra-abdominal sepsis or peritonitis
 - c. Necrotizing soft tissue infections
8. Renal and metabolic disorders
 - a. Acute kidney injury requiring dialysis or CRRT
 - b. Severe electrolyte disturbances
 - c. Significant metabolic acidosis
9. Need for intensive monitoring
 - a. Invasive hemodynamic monitoring (arterial or central lines)
 - b. Open abdomen management
 - c. Frequent interventions and close nursing care

Discharge criteria Surgical Intensive Care Unit (SICU)

1. Hemodynamic stability
 - a. Stable blood pressure without vasopressors
 - b. Adequate tissue perfusion and urine output
 - c. No active bleeding
2. Respiratory stability
 - a. Successfully extubated or stable on minimal oxygen
 - b. Adequate oxygenation and ventilation
3. Neurologic stability
 - a. Stable or improving level of consciousness
 - b. No need for intracranial pressure monitoring
 - c. Controlled seizures
4. Resolution of the primary condition
 - a. Postoperative condition stabilized
 - b. Infection controlled or improving
 - c. No immediate need for surgical re-intervention
5. Renal and metabolic stability
 - a. Stable electrolytes and acid base balance
 - b. Renal function adequate or manageable outside the ICU
6. Reduced need for intensive monitoring
 - a. Suitable for step-down unit or surgical ward
7. Logistical and ethical considerations
 - a. Transfer to high dependency unit or ward
 - b. Palliative or end-of-life care when appropriate